

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	酒精使用障礙症與酒精戒斷 Alcohol Use Disorder and Alcohol Withdrawal				
編號	A31000-Q03-W-L04	制定者	PSY 李家靜	公布日期	102 年 02 月 25 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	112 年 09 月 05 日
版本/總頁數	第 2.0 版/13 頁	審查者	曾翊捷	檢閱日期	114 年 08 月 07 日

一、目的

讓護理人員了解酒精使用障礙與酒精戒斷的定義、症狀、診斷準則、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，以提供適切之照護並達最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

依據美國精神醫學會制定的第五版精神疾病診斷統計準則(DSM-5)之診斷準則，酒精使用障礙症(Alcohol Use Disorder, AUD)是指反覆使用酒精，造成社會及職業功能障礙，以致影響日常生活，卻仍無法停止或控制飲酒的一種疾病。涵蓋了酒精濫用、酒精依賴、酒精成癮，還有俗稱的酗酒的狀況。酒精使用障礙症被視為一種腦部疾病，依嚴重程度分為輕度、中度及重度，若突然停止飲酒，則可能發生酒精戒斷(alcohol withdrawal)。

（二）症狀與診斷準則

根據 DSM-5(2014)酒精使用障礙症的診斷標準評估：在 12 個月期間內，符合 11 項標準中至少兩項，嚴重程度是依據患者的症狀其符合項目而定，分為輕度：存在兩至三種症狀；中度：存在四至五種症狀；重度：存在六種或更多症狀。

以下是 DSM-5 中的 11 個症狀，用於確定是否患有酒精使用障礙：

1. 比預期的還大量或長時間攝取酒精。
2. 持續渴望或無法戒除或是無法控制使用酒精。

主題名稱	酒精使用障礙症與酒精戒斷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L04	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	2/13

3. 大量的時間花在獲得酒精，使用酒精或從其效果中恢復過來的必要活動上。
4. 渴望或有強烈慾望要喝酒。
5. 反覆飲酒導致無法完成工作、學校或家庭的主要角色義務。
6. 儘管喝酒導致持續或反覆社交或人際問題，仍持續喝酒。
7. 因為喝酒而放棄或是減少重要的社交、職業或娛樂活動。
8. 在會傷害身體的情境下反覆喝酒。
9. 儘管知道有喝酒可能導致或加劇的持續性或反覆發生身體或心理問題，但仍繼續使用酒精。
10. 耐受性的定義為以下二項之一：a.明顯增加酒精量以達到中毒或預期效果；b.繼續使用相同量的酒後，其效果顯著減弱。
11. 戒斷的表現為下列情況之一：a.酒精的特徵性戒斷綜合徵；b.喝酒（或相當接近的物質，如安眠藥 Benzodiazepine）來解除或避免戒斷症狀。
12. 許多酒精使用障礙者在停酒後或飲酒量減少的 1 至 5 天內可能會出現的酒精戒斷(Alcohol Withdrawal)症狀，最先出現焦慮與厭食、虛弱，接下來是顫抖、噁心、嘔吐、自主神經系統亢奮狀態（如心跳加速、多汗、血壓增高、體溫上升）、失眠、焦慮與煩躁不安、眼皮嘴唇與雙手發抖，嚴重時還可能出現全身性痙攣、意識障礙以及妄想（多為視幻覺）、及震顫性譫妄等精神病症狀，酒精戒斷後譫妄經常會持續 3-5 天，治療後約在 48-72 小時左右緩解，但也有需要更長時間才能緩解，嚴重時甚至有生命的危險（如表一）。

表一：DSM-5 酒精戒斷診斷標準
A. 大量和長期喝酒後停止（或減少）。 B. 準則 A 停止（或減少）喝酒後幾個小時至數天出現以下一項（或更多）症狀 (A)自律神經功能過度活躍（例如流汗或脈搏超過每分鐘 100 下） (B)手抖增加 (C)失眠 (D)噁心或嘔吐 (E)短暫的視、觸、聽幻覺或錯覺 (F)精神動作激動(Psycho-Motor Agitation) (G)焦慮(Anxiety)

主題名稱	酒精使用障礙症與酒精戒斷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L04	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	3/13

(H)全面強直陣攣發作(Generalized Tonic-Clonic Seizure)

- C. 準則 B 的徵兆或症狀引起臨床上顯著苦惱或社交、職業或其他重要領域功能減損。
- D. 徵兆或症狀無法歸因於另一身體病況，且無法以另一精神疾病或另一種物質中毒或戒斷做更好的解釋。

(三) 常見檢查

1. 會談評估：

護理人員需要在病人入院初期收集完整個人飲酒史、藥物史及過去的生理及心理病史。但有時會因個案情緒或身體狀況無法配合，或收集資料不齊全，甚至是可信度存疑時，則需要臨床及實驗室的數據來協助診斷。

2. 血液檢查：

一般長期且大量飲酒者，體內各項血液及生化檢查指數多呈現異常，臚列部份指標性項目：

- (1) Ethanol：監測目前體內血液酒精濃度。
- (2) CBC：由於維生素 B12 及葉酸缺乏導致巨球性貧血(MCV>100fL)。
- (3) AST／ALT：酒精性肝炎病人會上升，但在其他肝臟疾病也會上升。酒癮病人常見 AST>ALT。
- (4) Bilirubin：升高。在其他肝膽疾病也會上升。
- (5) TG／Cholesterol：升高。在糖尿病、高血脂等疾病也會上升。
- (6) γ -GT：升高。但此項目也應考量在其他肝膽疾病也可能會上升。

(四) 常見治療

1. 支持性療法：

戒斷急性期應優先處理生理問題，監測生命徵象，減少外界刺激，提供舒適環境，使其獲得充分休息及營養，維持電解質及體液的平衡。

2. 藥物治療：

在酒精使用障礙症(Alcohol Use Disorder, AUD)的藥物治療策略上，可以分為兩個部分：一是「急性期的酒精解毒治療」，目的是避免戒斷症狀的發生，以苯二氮平類藥物(Benzodiazepines, BZDs)為主，合併維他命 B1(Thiamine)等之補充；

主題名稱	酒精使用障礙症與酒精戒斷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L04	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	4/13

第二個部分則是「維持治療」，用藥物降低個案之成癮行為，協助病人達到長期的酒精戒治。

- (1) 長期飲酒的病人會造成維生素及電解質的缺乏，一般會用 Thiamine 100mg IM QD，之後改用口服劑型 100mg QD，補充含葉酸的綜合維他命，及配合均衡飲食、水分、電解質及綜合維生素。低鎂血症也常發生，若發生應給予補充。
- (2) 酒精戒斷發生後就給予口服或靜脈注射苯二氮平類藥物(Benzodiazepines)以減少戒斷症狀。當戒斷症狀消失後，再逐日緩慢減低劑量。
- (3) 若有酒精戒斷引起的癲癇發作，可提高苯二氮平類藥物的劑量，或亦可合併給予抗癲癇藥劑。
- (4) 乙型交感拮抗劑、抗精神病劑也常被用來輔助治療戒斷症狀。乙型交感拮抗劑可以減低交感神經亢進造成的心悸、血壓升高、手抖等症狀。抗精神病劑則可降低酒精戒斷引起的妄想、幻覺及譫妄現象。
- (5) 恢復期階段，可嘗試戒癮藥物，如 Disulfiram、Naltraxone、Nalmefene 等藥物幫助病人持續戒酒。
- (6) 若出現藥物副作用持續未獲得改善，應與醫師討論是否調整劑量或改換藥物。

3. 心理治療：

- (1) 心理動力治療法：藉由心理動力治療幫助酒精使用障礙症病人，察覺與矯正他們認為此疾患根源的心理性問題。首先引導個案揭開與重構他們潛在的衝突，幫助他們改變飲酒過量的生活型態。
- (2) 行為療法：行為療法中的嫌惡療法(Aversion Therapy)，經常應用於酒精濫用和依賴，嫌惡療法是根據古典制約原理的方法，每次正當個案要服用藥物時，對其反覆給予不舒服的刺激，如此反覆配對運用後，他們被預期對物質有負面的反應，並失去對它的慾望（例如：用於酒精使用障礙症病人則是將喝酒行為與藥物誘發的反胃與嘔吐配對在一起）。其它方式還有隱蔽敏

主題名稱	酒精使用障礙症與酒精戒斷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L04	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	5/13

感法(Covert Sensitization)，另外個案也被教導其他替代行為，如酗酒者被教導以放鬆、靜坐來代替酒精減輕壓力。

- (3) 認知行為療法(Cognitive Behavioral Therapy, CBT)：近年的研究聚焦在如何直接促進認知功能恢復，進而改善對於酒癮的治療反應，此稱之為經驗依賴型恢復(Experience-Dependent Recovery)。針對酒癮設計的認知功能治療(Cognitive Remediation)，藉由改善執行功能、記憶力等認知功能，進而降低飲酒量、促進戒酒、改善人際與工作功能。例如，工作記憶訓練被證實可以提升酒癮者的工作記憶功能，進一步降低飲酒的自動化衝動，達到降低飲酒量的效果。注意力偏誤修正訓練(Attention Bias Modification, ABM)可減少因酒精誘發的中腦邊緣系統腦活性(Alcohol Cue-Induced Mesolimbic Brain Activity)，生物回饋訓練(Biofeedback)、呼吸訓練與有氧運動、正念療法亦可以透過改善工作記憶、執行功能、情緒調控等來增進酒癮治療的預後。
- (4) 動機增強療法(Motivation Enhancement Therapy, MET)：此療法強調時間與外在環境會對人的動機產生影響，藉由動機式晤談法(Motivational Interviewing)，協助個案探索內心想法並解決矛盾心理，察覺自身擁有改變的能力，增加其行為改變動機，從而改變不良生活習慣並選擇有利健康之行為，治療程序分別為建立動機、承諾計畫的執行、開始實施與持續改變。
- (5) 十二步驟治療法(twelve-step therapy)：通常為戒酒者匿名會(Alcoholics Anonymous, A.A.)使用，其防治原則包括：誠實承認自己的成癮行為、謙卑懺悔、以愛來補償犯錯、透過祈禱與默想獲得靈性察覺、藉由服務他人(藥癮者)找到生命意義等。目標在於預防重蹈飲酒之覆轍，當他們想要飲酒時，成員可尋求協會及其他人的協助。
- (6) 社會文化治療法：以社會文化方法為自助及住宅治療方案，就是在沒有專家協助，自行組織起來，去幫助其他人恢復，例如：戒酒者匿名會(A.A.)，是由一群匿名的酒精依賴病人獨立組成的團體，希望藉由互相的支持與經驗分享來幫助其他想要戒酒的人戒除酒癮，另一種社區預防方案，則是於

主題名稱	酒精使用障礙症與酒精戒斷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L04	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	6/13

學校、工作場所、活動中心、其他社區環境甚至透過媒體實施，這些方案在提供藥物教育、指導替代藥物的使用等。

(7) 家庭治療：以溝通互動模式，引導及促進家庭成員正向、坦誠的溝通，共同面對並解決家庭核心問題。

(五) 護理問題

1. 保護能力改變／酒癮使免疫力降低
2. 易對別人傷害或暴力／與物質的副作用有關
3. 焦慮感受／與自我概念、角色功能、健康狀態受到威脅有關
4. 缺乏營養／與沉溺於酒精、經濟因素有關
5. 睡眠障礙／與心理壓力、酒精之中毒或戒斷症狀有關
6. 思考過程異常／與酒精之中毒或戒斷症狀有關
7. 知覺感受變異／與酒精之中毒或戒斷症狀有關
8. 失去因應能力／與不適當的因應方式有關
9. 健康保護能力不足／與缺乏資訊、錯誤解釋資訊有關

(六) 護理措施

1. 保護能力改變／酒癮使免疫力降低
 - (1) 注意觀察生命徵象。
 - (2) 監測血液檢查值並觀察其變化。
 - (3) 評估淋巴系統注意是否有淋巴結腫大或疼痛情形。
 - (4) 瞭解病人酗酒的原因，協助其解決問題或減輕壓力源。
 - (5) 注意觀察病人的環境是否安全，避免外傷。
 - (6) 觀察病人的活動能力，注意有無軟弱疲倦情形。
 - (7) 注意觀察病人是否繼續飲酒，若飲酒應給予勸阻。
 - (8) 向病人解說飲酒對身體的不良影響。
 - (9) 注意病人進食情況，食慾是否改善，營養是否足夠，以增加免疫力。
 - (10) 注意是否免疫力下降，提供適當的防護措施。

主題名稱	酒精使用障礙症與酒精戒斷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L04	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	7/13

2. 易對別人傷害或暴力／與物質的副作用有關

- (1) 引導思考其他的選擇或替代方案，以減少暴力之產生，如：深呼吸可放鬆並減輕焦慮；運動、散步或提供保護室給予大喊、搥打海綿牆、以發洩情緒。
- (2) 提供一個安靜、清爽的環境空間，以減少環境刺激。
- (3) 評值目前的暴力危險因子，如：年輕、男性、暴力史、壓力、物質濫用史等。
- (4) 運用會談了解病人的需要及感受，教導質疑自己使用暴力行為之情況。
- (5) 親視服藥並觀察是否出現藥物副作用。
- (6) 藥物衛教服用藥物的重要性，視需要時給予依臨時醫囑藥物幫助控制行為。
- (7) 監測瀕臨暴力發作的症狀，如：握拳、說話音量大、咬牙切齒等，避免單獨接觸正憤怒中的病人、注意安全距離（2-3 呎）、勿觸摸病人，呼叫尋求其他工作人員支援。
- (8) 聯絡醫師評估約束或保護隔離的必要性，約束病人的身體以控制暴力行為，防止進一步的傷害。

3. 焦慮感受／與自我概念、角色功能、健康狀態受到威脅有關

- (1) 評估個案焦慮程度及主要引起焦慮之原因。
- (2) 時常給予探視，提供一致性且可靠的態度並表示關懷，增加安全感以減輕焦慮。
- (3) 與個案建立信任關係，如：提供選擇的機會、避免不必要的衝突及允許並接受其真誠的情緒表達等。
- (4) 當出現焦慮時，引導使用轉移注意力、放鬆技巧、冥想來緩解焦慮程度。
- (5) 衛教緩解或消除焦慮的方法並引導練習此技巧，如：轉移注意力、放鬆技巧、冥想或改變對威脅之看法等。
- (6) 壓力情境發生前提供適當之訊息，增加其控制感並減少不確定感。
- (7) 介紹類似之個案認識，彼此經驗分享及心得交換，增強其學習改變的動機。
- (8) 學習確認焦慮的來源及本身對焦慮的感受。

主題名稱	酒精使用障礙症與酒精戒斷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L04	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	8/13

(9) 透過定期會談、討論引導個案思考適合自己對問題解決因應技巧，增加問題處理能力，提昇自我控制能力。

4. 缺乏營養／與沉溺於酒精、經濟因素有關

- (1) 監測生命徵象。
- (2) 給予清淡簡單及溫和的食物。
- (3) 定期測量病人的體重。
- (4) 監測熱量及營養的攝取。
- (5) 必要時提供轉介或諮詢與健康照護小組之其他成員。
- (6) 必要時提供病人有關飲食衛教及計畫的轉介。

5. 睡眠障礙／與心理壓力、酒精之中毒或戒斷症狀有關

- (1) 瞭解個案以前的睡眠習慣，情況許可盡量配合（如用自己的枕頭、被子）。
- (2) 瞭解個案不適應哪些環境，協助解決。
- (3) 提供正常的作息型態，不鼓勵白天睡覺。
- (4) 鼓勵白天多進行一些活動，如散步、閱讀雜誌、找其它病人閒聊等，使夜晚容易入睡。
- (5) 提供個案舒適的環境，以促進睡眠或休息，例如：關燈、避免噪音干擾。
- (6) 鼓勵睡前做柔和的床上運動，或喝杯溫飲料，協助入睡。
- (7) 將治療或護理集中，讓個案有較長的睡眠時段。
- (8) 指導個案各種放鬆的技巧，幫助睡眠。
- (9) 必要時依醫囑給予鎮靜安眠藥物，協助入睡。

6. 思考過程異常／與酒精之中毒或戒斷症狀有關

- (1) 不要與病人爭論或否認其信念，或企圖說明讓他相信其妄想不是真的。
- (2) 出現合乎現實想法時給予正向加強。
- (3) 安排活動如打球、唱歌、聽音樂等以轉移注意力。
- (4) 協助病人區分妄想與現實。
- (5) 若拒絕治療時，先暫時離開，稍候再試。

主題名稱	酒精使用障礙症與酒精戒斷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L04	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	9/13

- (6) 傳遞訊息時言語清晰明確。
- (7) 會談時強調並集中注意於現實的情境，談論真實的人與事。
- (8) 鼓勵其說出內在的焦慮害怕及不安全感等，並予傾聽同理。
- (9) 與其討論妄想對其日常生活所帶來的困擾。
- (10) 避免開玩笑及隨意碰觸病人。
- (11) 讓病人了解雖然護理人員並不同意其妄想但可接受他有妄想存在。

7. 知覺感受變異／與酒精之中毒或戒斷症狀有關

- (1) 給予病人及其重要親友有關於此症狀的衛教。
- (2) 如果病人的能力許可，鼓勵其發展對自我行為負責及控制的能力。
- (3) 依醫囑給予常規或需要時的抗精神病及抗憂鬱藥物。
- (4) 促進清晰及開放式的溝通模式，鼓勵病人適度地表達感覺。
- (5) 與病人建立信賴的人際關係，盡量安排固定的照護者。
- (6) 記錄病人出現幻覺時的行為，提供病人討論其幻覺的機會。
- (7) 將討論的重點放在幻覺產生時病人的感受，而非幻覺的本身（例如：對病人說：「你看起來好像很害怕的樣子。」）。
- (8) 當病人問及時，明確地指出你並沒有感受到該刺激。
- (9) 當病人無法控制自己行為時，提供病人及其周圍的人安全和舒適上的需要（例如：加以約束、限制活動區域、拘禁和隔離）。
- (10) 鼓勵病人運用討論的方式說出其感覺及衝動，而不要直接反應在行為上。
- (11) 鼓勵病人與其信賴的人一同驗證其幻覺的真實性。
- (12) 監控並調節環境中之活動以及刺激的程度。
- (13) 監測病人的幻覺是否有暴力或自我傷害傾向。
- (14) 避免與病人爭議幻覺的真實性。
- (15) 讓病人參與一些以現實為主的活動，將病人帶離幻覺狀態。

8. 失去因應能力／與不適當的因應方式有關

- (1) 鼓勵協助表達並確認其面對壓力或疾病事件之感受。

主題名稱	酒精使用障礙症與酒精戒斷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L04	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	10/13

- (2) 提供觀察到的行為及情緒狀態表現，對於其言行表現，能以真誠開放的態度來與之討論。
- (3) 與之探討其問題及困擾，協助認清其問題及需要；當出現不合理信念時，應予澄清觀念。
- (4) 互動過程中鼓勵並協助病人討論其想法和感覺，藉由轉移注意力、遠離、放鬆方法及傾聽等方法來紓解緊張情緒。
- (5) 衛教情緒管理方法，增加因應壓力，如：放鬆技巧、轉移注意力等。
- (6) 提供演練及應用之機會。
- (7) 以簡短、頻繁接觸病人方式，建立治療性人際關係適時提供人、事、物等周遭訊息。

9. 健康保護能力不足／與缺乏資訊、錯誤解釋資訊有關

- (1) 安排電話追蹤以評估問題解決的效果及其他支援需求。
- (2) 詢問病人及其重要親友以確認其對所困擾問題之解決方法及障礙。
- (3) 適當地使用案例來促進病人問題解決的技巧。
- (4) 協助病人列出所有能解決問題的策略之優先次序。
- (5) 協助病人決定解決問題的方法。
- (6) 協助病人確認即將發生、發展中或正處於危機的情境，以及危機對個人及家庭生活之影響。
- (7) 適當地協助病人確認現存的資源即可採取的措施。
- (8) 鼓勵病人以較合宜的學習取代不合宜的習慣。
- (9) 協助病人適應未來角色的改變。
- (10) 適當地建議病人閱讀相關書籍及文獻。
- (11) 提供病人參考資料的資源，如：(衛教單張及參考書籍)。
- (12) 提供與病人行為有關且符合現實期望的資訊。
- (13) 衛教個人正常的發展過程及應有的行為。
- (14) 勸告病人在承受壓力下不宜做決策。

主題名稱	酒精使用障礙症與酒精戒斷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L04	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	11/13

(15) 適當地邀請家屬或重要親友一起參與問題解決及危機處理的過程。

(七) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 李若琦、楊凱鈞(2020)·臺灣酒癮藥物治療之發展趨勢·臨床醫學月刊，85(4)，202-205。
- (二) 林君屏、施雅雯、洪翠妹、鄒淑萍(2019)·運用動機式晤談法於一位酒精成癮個案之護理經驗·精神衛生護理雜誌，14(1)，34-43。
- (三) 林梅鳳、陳姝蓉、洪翠妹(2021)·物質相關及成癮障礙症之護理·於蕭淑貞（總校閱），精神科護理概論-基本概念及臨床應用（十版，524-598 頁）·台北市：華杏。
- (四) American Psychological Association. (2014)·DSM-5 精神疾病診斷準則手冊（臺灣精神醫學會譯）·台北市：合記圖書出版社。（原著出版於 2013）
- (五) National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. (2021). Turning Discovery Into Health(NIH NO. 301-443-3860). <https://www.niaaa.nih.gov>.

七、附件

(略)

主題名稱	酒精使用障礙症與酒精戒斷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L04	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	12/13

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
102.02.25	1.0	新制定	102 年 02 月 25 日護理部照護標準委員會通過；102 年 02 月 25 日公布
103.06.30	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	1.1	1. 說明（二）症狀新增補充說明”或稱震顫性譫妄” 2. 參考資料文獻部份內容更新	103 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
104.08.31	1.2	1. 第三項第（二）目說明新增內容 2. 第三項第（三）目之 1 增加實證內容 3. 增刪第六項參考資料及修訂 APA 格式	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	1.3	1. 第三項第（二）新增內容。 2. 參考文獻新增於內文。 3. 第六項參考資料新增。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	1.4	1. 原主題名稱：酒精濫用與依賴；改為酒精依賴與戒斷。 2. 第三項第（一）、（二）、（三）、（四）、（六）目內容部份增刪。 3. 更新第六項參考資料。	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
107.06.29	1.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	1.5	1. 第三項第二、三目內容部份刪減。 2. 第六項參考資料新增。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.09.23	1.6	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項說明內容錯別字修訂。 3. 第三項第四、六目說明內容部份增刪及新增參考文獻。 4. 第三項第六目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 5. 第六項參考資料新增及部分內容修正。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.18	1.7	1. 主題名稱酒精依賴與戒斷，修訂為酒精使用障礙與酒精戒斷。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過；109 年 08 月 12 日護

主題名稱	酒精使用障礙症與酒精戒斷	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L04	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	13/13

修正日期	版本	修正說明	備註
		2. 第一項刪除酒精依賴與戒斷，修訂為酒精使用障礙與酒精戒斷。 3. 第三項第一、二、四、六目內容修訂及參考文獻增刪。 4. 第六項參考資料部分增刪。	理長會議通過;109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.09.07	1.8	參考文獻於內文引用呈現方式，依 APA 格式第七版規範修訂	110 年 08 月 05 日照護標準組會議通過； 110 年 08 月 11 日護理長會議通過;110 年 09 月 07 日督導會議通過公布。
111.09.06	1.9	1. 第三項第一、二、四目之說明內容修訂。 2. 第三項第五、六目護理問題修正。 3. 第六項參考資料文獻部份增刪及更新。 4. 內文參考文獻統一刪除。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過;111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.09.05	2.0	1. 第三項第一、二目內容修訂。 2. 第三項第五目之 7.、第六目之 7.護理問題修正。 3. 第六項參考資料部分增刪。	112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過； 112 年 08 月 09 日護理長會議通過;112 年 09 月 05 日督導會議通過公布。
113.08.08	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.08.07	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	